



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : اسماء محمد حسن عطيه
المحافظة : الجيزة
الحى / المدينة : بولاق الدكرور
العنوان : =
رقم البطاقة : 27907242103201 رقم التليفون : 01207183210
تاريخ تسجيل الإستمارة : 23-09-2026
العمر (تاريخ الميلاد) : 24-07-1979 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.
تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: اسماء محمد حسن عطيه National ID: 27907242103201	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين


 جمهورية مصر العربية
 وزارة الداخلية
 إدارة جوازات السفر
 جواز سفر
 ١٤ جازة سفر
 ٢٠٢٢ - ٢٠٢٤
 ٢٧٩٠٧٢٤٢١٠٢٢٠١
 IL0156777

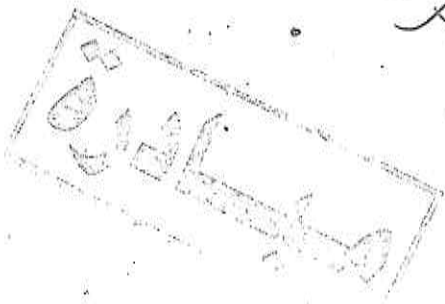



 جمهورية مصر العربية
 وزارة الداخلية
 إدارة جوازات السفر
 جواز سفر
 ١٤ جازة سفر
 ٢٠٢٢ - ٢٠٢٤
 ٢٧٩٠٧٢٤٢١٠٢٢٠١
 ٢٠٢٧/٠٧/٢٨ حتى

٢٠٢٢/٠١/٠١
 ٢٧٩٠٧٢٤٢١٠٢٢٠١
 ٢٠٢٧/٠٧/٢٨ حتى

١
 ٢٠٢٧/٠٧/٢٨ حتى

فتح ملف تصاريح
 و افاضل
 ٢٠٢٢/٠٧/٢٨



MDT FORM 81 12/2015 G

Name	اسماء محمد علي	MRN	2210
Age	46 y.o	ID	C.O
Menopausal status	premen	Phone	01207183210
NRS SCORE		Marital status	married
BMI		Family history	-ve
CO morbidity	DM	REASON OF MDT	Cy9. v Cx9. 1. 2. 3.

Clinical Data

BX:	IDC GII			R	DS 0-I	L
ER:	PR:	HER 2:	Ki67:			
8/8	8/8	-ve.				
Sonomammography: reviewed NACT ACX4 → T4 → Lt MRM → post op y p T2, y p N1						
Mets Workup: recent Port, AI + 2nd dex since 5-2024 till now. CT chest 1st contrast 6-7-22 → scattered Pulm				TNM CT3 N1		

Recommendations: nodules largest 8mm.
Multiple mediastinal LN (perivascular, Central, ortho-pulm -
largest about 1.9 x 1.2 cm Subcentral LN)
US 1.6 x 1.4 cm of CT ch 13-11-2023
⇒ CT chest 1st contrast (16-10-2025) ⇒

MDT OUTCOME & PLAN Multiple Pulm nodules largest 8mm
- mediastinal LN largest 2.1 cm -
for radiology op 2. further management
Stable tiny nodes + LN stable all time Engage

Keep on A+ 25mg + CT 16/10/25

SIGNATURE					
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
M. Kasey		Nerv. Radu			

Patient Name : الأستاذ / اسماء محمد حسن عطيه	Request No. : 13000351
Patient No. : 27907242103201	Request Date : 22/05/2024
Path No. : 1705/24	Verification Date : 01/06/2024
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age : 44 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer, post NACT.

Nature Specimen: Left modified radical mastectomy specimen.

Gross Examination:

- * Procedure: Left MRM measured 21x16x7 cm, with covering skin ellipse measured 20x11 cm.
- * Tumor extent: A greyish white firm tumor bed site.
- * Size: 2.5x2x1 cm.
- * Skin: Nipple & areola looked unremarkable grossly.
- * Distance from margins: 5 cm away from deep margin.
- * Lymph nodes number and size: 12 L.Ns up to 1.5x1.5x1 cm.
- * 8 Blocks:
- 1:3- T.B.S., 4- Deep margin., 5- N & A., 6:8- Lymph nodes.
- * Gross was done by; Dr. Rufida Abdallah.

Microscopic Examination:

- * Histological type: Residual viable invasive lobular carcinoma.
- * Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+2) Grade II.
- Maximal tumor diameter 2.5 cm.
- Actual tumor cellularity: 10%.
- * Ductal carcinoma in situ: Focally detected (10 %).
- * Skin: Free.
- * Lymph nodes: Positive metastatic deposits in two out of twelve lymph nodes (measuring 1.5 cm in maximum dimension), L.N (2/12).
- * Resection Margins: Free.
- * Histologic response to therapy: Pathological partial response to therapy.

Verified by :

Dr.Duaa Mohamed

Printing Date : 06/06/2024 08:42:44

Page 1 of 2

Printing By : .marwa mohamed youss

CAP
ACCREDITED

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name	: الأستاذة / اسماء محمد حسن عطيه	Request No.	: 13000351
Patient No.	: 27907242103201	Request Date	: 22/05/2024
Path No.	: 1705/24	Verification Date	: 01/06/2024
Sex	: Female	Financial Category	: نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age	: 44 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Diagnosis:

- Left breast cancer post NACT, Left modified radical mastectomy specimen:
- Residual viable invasive lobular carcinoma, Grade II, with focal DCIS (10%).
 - Maximal tumor diameter: 2.5 cm.
 - Actual tumor cellularity: 10%.
 - Resection Margins: Free.
 - Skin: Free.
 - Lymph nodes: Positive metastatic deposits in two out of twelve lymph nodes (measuring 1.5 cm in maximum dimension), L.N (2/12).
 - Histologic response to therapy: Pathological partial response to therapy.
 - Stage: ypT2, ypN1a.
 - RCB: 3.32, RCB class III.

Signature
Prof. Dr. Gamal Abd-El-Aty.
Dr. Menna Nabil.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

Printing Date : 06/06/2024 08:42:44

Page 2 of 2

Printing By : .marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

PATIENT NAME: ASMAA MOHAMMED HASSAN ATEA
GENDER: Female
DATE : 02-Dec-2023 11:04 AM

PATIENT ID: 10123235
AGE: 44 y
ORDER: 2606357,26067

Clinical indication - all studies
Left breast cancer pathologically proven IDC
Report: - all studies

CONTRAST ENHANCED SPECTRAL MAMMOGRAPHY, 3D DIGITAL TOMOSYNTHESIS, AND COMPLEMENTARY ULTRASOUND

INDICATION:

- Check-up.

TECHNIQUE:

- Contrast Enhanced Spectral Mammography CC and MLO view, 3D Tomosynthesis.
- Complementary ultrasound

REPORT:

- - Scattered fibroglandular densities (ACR b).
- Left breast central outer speculated dense mass lesion with surrounding scattered irregular dense nodules .
- By CESM show left breast outer central pathologically enhancing irregular mass lesion measuring about 6.3 x 3.8 x 3 cm in CC , AP and TS dimension . Associated with non mass pathological enhancing of unhealthy parenchyma .
- Multiple left barest pathologically enhancing suspicious nodules seen at outer central and retro areolar region .
- The distance between the nearest nodule to nipple and the farthest one about 12 cm in CC view .
- Corresponding by ultrasound as left breast 3 o'clock ill defined hypoechoic infiltrating mass lesion with area of parenchymal distortion extending from 3 to 6 o'clock and retro areola region with multiple scattered hypoechoic nodules likely satellites lesions
- No spiculated mass lesions or microcalcific clusters in right breast .
- - 3D Digital Tomosynthesis confirmed these findings.
- - Contrast Enhanced Spectral Mammography showed mild background

PATIENT: ASMAA MOHAMMED HASSAN ATEA, 10123235734, Female, 44 y
Report version 1, 02-Dec-2023 12:08 PM



Patient Name: Asmaa Mohamed Hassan	Date : 16/10/2025
Exam : C.T CHEST	Age : 46 Year(s)
Medical ID: 4280/2023	Pat. ID: 43973

MULTISLICE NON CONTRAST CT SCAN OF THE CHEST:

TECHNIQUE: Multislice axial CT images of the chest with multiplanar reconstruction. No IV contrast was used.

FINDINGS:

Status follow up, in reviewing the previous limited study report, the current study showing:

- evidence of left mastectomy.
- Multiple bilateral scattered solid pulmonary nodules, largest one seen at right middle lobe measuring about 8mm.
- Still noted right middle lobe subsegmental atelectasis.
- Right middle lobar, lingual and bilateral lower lobar multiple thick fibrotic parenchymal bands.
- Multiple mildly enlarged prevascular, paratracheal, aorto-pulmonary and subcarinal mediastinal lymph nodes, the largest one seen at subcarinal measuring about 2.1cm in its short axis.
- No plural or pericardial collection.
- No gross cardiomegaly
- Dorsal spondylosis.
- Upper abdominal cuts show fatty liver

Dr. Nourhan Mohamed, MD

Patient Name: Asmaa Mohamed Hassan	Date : 27/07/2025
Exam : C.T CHEST	Age : 46 Year(s)
Medical ID: 4280/2023	Pat. ID: 43973

Patient Name: Asmaa Mohamed Hassan

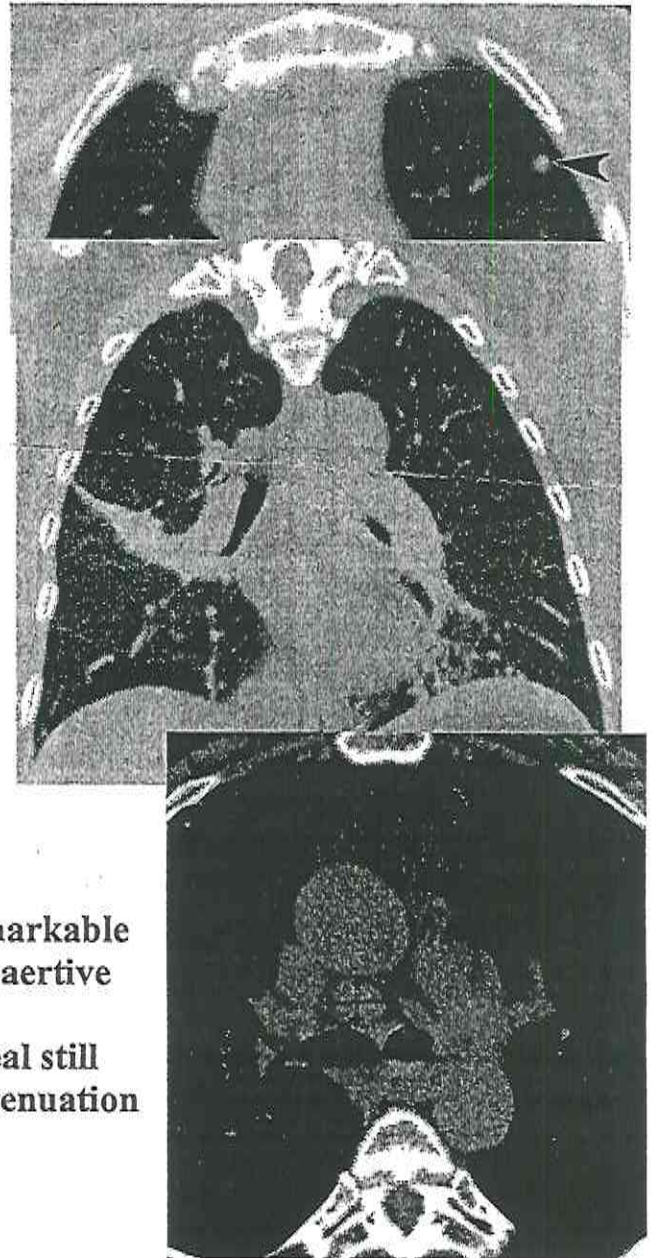
Date: 29-7-2025 *Compared to 13.11.2023.*

C.T. SCAN OF THE CHEST WITHOUT CONTRAST / HRCT

Axial contiguous thin cuts were taken through the chest without I.V. contrast injection.

FINDINGS:

- Stationary course as regards :
 - the bilateral scattered pulmonary nodules, largest at the middle lobe measuring 8 mm.
 - right middle ,lingular and bilateral lower lobar thick atelectatic bands and fissural thickening and small subsegmental consolidations.
 - multiple enlarged mediastinal (perivascular, retrocaval, aorto-pulmonary, carinal and subcarinal) lymph nodes largest measuring about 19 x 12 mm at the aortopulmonary lymph nodes as compared to 1.6 x 1.4 cm at the perivascular group in the previous study .
- No CT evidence of abnormal areas of crazy paving.
- Patent tracheo bronchial tree with no abnormal bronchial dilatation.
- No pleural or pericardial effusion.
- Average size of the heart is noted.
- The included lower neck cuts are unremarkable
- Still noted diffuse dorsal spondylodegenerative changes
- The scanned upper abdominal cuts reveal still noted mild diffuse decreased hepatic attenuation denoting fatty liver.



IMPRESSION:-

Rather stationary course regrading:

- Bilateral scattered pulmonary nodules, mostly metastatic.
- Bilateral basal atelectatic bands, fissural thickening and small subsegmental consolidations as described.
- Multiple mildly enlarged mediastinal lymph nodes.

Much obliged,

Mona Ali, MD